

1. Une femme de 63 ans consulte pour une lombalgie intense, permanente, diurne et nocturne, apparue subitement il y a 4 jours en se penchant en avant, sans traumatisme. Pas d'irradiation, ni fièvre, ni symptôme urinaire, ni neurologique.

Bonne santé habituelle sans antécédent notable. Tabagisme dès l'âge de 18 ans avec consommation actuelle de 20 cig/j.

A l'examen: bon état général, algique, BMI= 19 kg/m², T°= 36.6°, pouls = 84/min, tension artérielle =120/80 mmHg. Loges rénales souples, indolores. Percussion douloureuse au niveau de l'épineuse L3. Examen neurologique sans déficit moteur, ni sensitif, ni réflexe.

Quelle investigation diagnostique proposez-vous en 1^{ère} intention ?

- A. Bilan phospho-calcique
- B. dosage du facteur rhumatoïde
- C. CT-scan de la colonne lombaire
- D. IRM de la colonne lombaire
- E. Aucun examen complémentaire, antalgie efficace

2. Une patiente de 45 ans consulte pour une fatigue depuis environ 1 an, qui s'aggrave et l'inquiète. La fatigue est présente du matin au soir. Elle manque d'énergie pour ses activités habituelles mais n'est pas triste et n'a pas de trouble du sommeil. Son appétit est conservé et son poids est stable. Menstruations régulières. Elle n'a pas d'autre plainte ni d'antécédent médical notable. Elle ne fume pas de tabac, consomme rarement de l'alcool et jamais de drogue illicite ni de médicament. Depuis quelques années, son alimentation est essentiellement d'origine végétale (flexitarienne). Elle est mariée et a 2 enfants de 15 et 12 ans. Elle est juriste dans l'administration publique.

A l'examen: $T^{\circ}=36.3^{\circ}$, pouls= 96/min, TA=115/70 mmHg, BMI= 26 kg/m². Peau normale sans ictère. 3 ganglions cervicaux postérieurs indolores de 0.5 cm, autres aires ganglionnaires sp. Thyroïde sp. Examen cardio-vasculaire, pulmonaire et abdominal normal.

Quel est le diagnostic le plus probablement responsable de cette fatigue ?

- A. Trouble dépressif
- B. Lymphome
- C. Hypothyroïdie
- D. Anémie ferriprive
- E. Syndrome de fatigue chronique

3. Une patiente de 32 ans vous consulte en raison de brûlures mictionnelles avec pollakiurie depuis 3 jours ainsi que de fièvre à 38.2° et une douleur lombaire G depuis hier. Elle n'a pas de prurit vulvaire. Elle a eu 3 épisodes similaires au cours des 5 dernières années.

A l'examen clinique: afébrile, normocarde, normotendue. L'abdomen est sensible dans la région suspubienne, indolore ailleurs, sans péritonisme. Les bruits abdominaux sont normaux. Les loges rénales sont souples, la G est modérément douloureuse et la D est indolore.

La bandelette urinaire montre une leucocyturie 3+, des traces de sang mais pas de nitrites.

Quelle stratégie de prise en charge lui proposez-vous?

- A. Nitrofurantoïne 3 x 100 mg/j durant 5 jours
- B. Culture d'urine & norfloxacine 2 x 400 mg/j durant 3 jours
- C. Culture d'urine & ciprofloxacine 2 x 500 mg/j durant 7 jours
- D. Culture d'urine & traitement antibiotique selon le résultat
- E. US abdominal

4. Un patient de 40 ans vous consulte pour un état fébrile, une rhinorrhée, un léger mal de gorge depuis 3 jours et une forte toux depuis 24h, gênant le sommeil. Le patient n'a pas mesuré sa température. Ce matin, il a des céphalées frontales et ne va pas au travail. Pas d'odynodyphagie.

Examen clinique: T=37.8°C. Fond de gorge érythémateux sans exsudat, avec écoulement postérieur. Petites ganglions cervicaux antérieures (<0.5 cm) indolores à la palpation. Douleur à la percussion des sinus frontaux ddc. Tympan sp ddc. Percussion et auscultation pulmonaire sp.

Quelle est votre stratégie de prise en charge?

- A. Test streptococcique rapide
- B. Traitement empirique d'amoxicilline-clavulanate durant 7 jours
- C. Anti-inflammatoire & vasoconstricteur nasal sans examen compl.
- D. Examens sanguins: formule sanguine complète et CRP
- E. Radiographie standard des sinus

5. Un patient de 58 ans, connu pour broncho-pneumopathie obstructive chronique avec syndrome obstructif non réversible modéré (VEMS=65% prédit), consulte car sa dyspnée progresse sous traitement d'anticholinergique inhalé.

Il fume depuis l'âge de 14 ans et consomme 30 cigarettes/jour. Il n'a jamais cessé de fumer mais envisage l'arrêt du tabac si vous pouvez l'aider avec un traitement efficace. Il a une dépendance à l'alcool qu'il aimerait aussi réduire.

Laquelle des affirmations suivantes est correcte en première intention ?

- A. Vous prescrivez un bronchodilatateur β_2 -stimulant à courte durée d'action
- B. Vous employez une approche motivationnelle car l'arrêt du tabac ralentira l'évolution de sa maladie
- C. Une substitution nicotinique est contre-indiquée car il a probablement une cardiopathie ischémique
- D. Un sevrage simultané d'alcool et tabac est contre-indiqué
- E. Vous prescrivez de suite du bupropion pour le sevrage de tabac

6. Une femme de 42 ans consulte pour des épisodes occasionnels de vertiges sévères avec nausées, vomissements, acouphènes et sensation d'oreille pleine. Son 1^{er} épisode date de 3 ans et, depuis lors, elle a eu 6 épisodes durant chacun entre 6 heures à 1-2 jours. Elle n'a pas de symptôme actuellement. Elle ne prend aucun traitement mais doit souvent rester au lit et manquer 1-2 jours de travail durant ces épisodes. Elle a une anamnèse familiale de migraine, mais elle ne ressent ni céphalées ni troubles visuels durant les épisodes de vertiges.

L'examen physique, incluant les signes vitaux, est normal. Il n'y a pas de nystagmus ni de déficit auditif, les épreuves de Rinné et Weber sont normales. Son IRM cérébral est normal.

Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. Vertige périphérique paroxystique bénin
- B. Neuronite vestibulaire
- C. Maladie de Ménière
- D. Neurinome du nerf acoustique
- E. Migraine sans céphalée

DÉPISTAGES RECOMMANDÉS: FEMMES (II)

- Mesure de poids, taille & BMI 1x/3ans, >18 ans B
- Glycémie à jeun ou HbA1C, 1x/1-3ans, >40 ans B
- Minéralométrie ≥ 65 ans ou >50ans + haut risque B
- Questionnaire pour dépression B
Dans le dernier mois, avez-vous ressenti manque d'intérêt ou plaisir dans activités
Dans le dernier mois, vous êtes-vous senti triste/déprimé
- Sérologies VIH & syphilis (VDRL) chez personnes avec activité sexuelle A
- PCR urinaire/frottis vaginal Chlamydia + gonocoque, <25ans & à risque B

DÉPISTAGES RECOMMANDÉS: FEMMES (I)

- | | |
|---|-----------------------|
| • Frottis col utérin (Pap test) 1x/3a, > 21-65 ans | A |
| OU Test HPV 1x/5 ans, 30-65 ans | BA |
| • Recherche sang fécal occulte 1x/2ans, 50-75 ans | A |
| OU colonoscopie 1x/10ans, 50-75 ans | A |
| • Mammographie 1x/2 ans, 50-74 ans | B (décision partagée) |
| Mammographie 1x/2 ans, 40-49 ans | C (décision partagée) |
| • Mesure pression artérielle 1x/3ans, >18 ans | A |
| Mesure pression artérielle 1x/an, >18 ans | A |
| • Dosage lipides 1x/2-5ans dès 40 ans | B |
| • Moins de 40 ans = décision partagée | |
| • Oui, lors de haut risque CV (dyslipidémie familiale, diabète) | |

7. Une patiente de 47 ans vous consulte pour un bilan de santé.

L'anamnèse ne révèle aucune plainte. Elle est inquiète d'avoir un problème cardiaque après un infarctus du myocarde chez son frère âgé de 42 ans.

Dans ses habitudes, on note: arrêt du tabac il y a un an (20 cig/jour durant 18 ans), boit de l'alcool lors d'occasions sociales (1-2 verres 1-2x/sem), pas de drogue illicite, alimentation équilibrée, pas d'activité physique régulière, activité sexuelle avec son partenaire habituel sans protection. Anamnèse familiale négative. Examen gynéco avec frottis du col normal il y a 1 an.

L'examen clinique est normal avec une tension artérielle de 125/78 mmHg et un BMI de 24 kg/m²

Quel examen de dépistage recommandez-vous à cette patiente?

- A. Dosage sanguin de ASAT, ALAT, γ -GT
- B. Dosage sanguin du cholestérol total et HDL
- C. ECG
- D. Mammographie
- E. RX thorax vu les 18 ans de tabagisme



8. Un homme de 67 ans consulte pour son suivi régulier. Dans ses antécédents, on note une maladie coronarienne, une hypertension, et une dyslipidémie. Depuis 1 an, il a des difficultés à maintenir une érection. Il a une vie de couple heureuse, profite de sa retraite et ne se sent ni déprimé ni anxieux. Sa médication inclut metformine, tamsulosine, simvastatine, lisinopril, métoprolol, aspirine et nitroglycerine sublinguale en cas de douleur thoracique.

P = 64/min TA = 128/76 mm Hg. L'examen uro-génital montre une prostate agrandie, lisse, symétrique, sans nodule; ses testicules sont de taille et consistance normales; le pénis est normal sans plaques fibreuses.

Quel est le traitement initial le plus approprié pour ce patient?

- A. Sildénafil
- B. Tadalafil
- C. Alprostadil intra-caverneux
- D. Implant pénien
- E. Testostérone

9. Un homme de 28 ans présente une température élevée, des frissons, des céphalées, une diarrhée durant 3 jours puis une constipation opiniâtre 10 jours après son retour d'Inde. Il consulte au 3^{ème} jour des symptômes. Il n'a fait aucun vaccin avant le départ ni pris de prophylaxie durant le voyage.

A l'examen: température=39.8°C, pouls=72/min, TA=120/70 mmHg. Peau normale sans lésion. Pas d'adénopathie. Abdomen diffusément sensible, sans péritonisme, pas d'hépatomégalie, rate non palpable, bruits intestinaux normaux. Reste de l'examen normal.

Examens de laboratoire: Hb = 135 g/l, leucocytes = 5.2 G/l (N: 4.5-11), Thrombocytes 250 G/l (N: 250-500). CRP=98 mg/l (N: < 10)

Parmi ces propositions, quel est le diagnostic le plus probable?

- A. Amibiase
- B. Paludisme
- C. Leptospirose
- D. Fièvre typhoïde
- E. Grippe à Influenza

RÉDUCTION RISQUE PÉRI-OPÉRATOIRE

- Maintenir: β -bloquants, anticalciques, IEC, sartans, nitrés, statines, IPP, bronchodilatateurs, corticoïdes, neuroleptiques, antidépresseurs, antiépileptiques, immunomodulateurs
- Arrêter: AINS, antidiabétiques oraux (metformine, inhibiteur SGLT2 ou sulfonyluré), oestrogènes, diurétiques, insuline (stop rapide, diminuer lente)
- Aspirine:
 - Maintien: chirurgie mineure, infarctus/angioplastie/AVC <6mois
 - Arrêt: 7-10j avant chirurgie majeure (ou si en prévention primaire)
- Clopidogrel:
 - Arrêt: 5-7j avant toute chirurgie
 - Retard chirurgie & maintien: stent nu (4-6sem), stent élution (12 mois)
- Anticoagulants oraux:
 - Arrêt: 3-5j si chirurgie majeure (héparine si haut risque thrombotique)
 - Maintien: chirurgie mineure
- Arrêt du tabac idéalement > 8 sem avant opération

10. Un homme de 64 ans consulte pour bilan pré-opératoire avant une prothèse totale du genou D pour une arthrose avec des douleurs importantes du genou D qui le limitent à la marche.

Antécédents: infarctus myocarde avec angioplastie & 2 stents il y a 4 ans, diabète type II, HTA. Ø douleur thoracique, Ø dyspnée, peut monter 2 étages sans symptôme, marche limitée à 200 m à cause douleurs du genou. TTT: aspirine, metoprolol, lisinopril, atorvastatine, metformine et empagliflozine.

TA=140/80, P=60/min, BMI=30. Auscultation cardio-pulmonaire N. Pas de turgescence jugulaire ni oedème. Créatinine =102 μ M/l, Na+=138 mmol/l, K+=4,1 mmol/l, HbA1c 6,9%. ECG: ondes Q DII, DIII, AVF, anomalies ST-T aspécifiques, signes HVG. RX thorax normale.

Quelle est la meilleure stratégie pré-opératoire pour son problème cardiaque?

- A. Scintigraphie au thallium avec effort
- B. IRM cardiaque de stress
- C. Coronarographie
- D. Echographie de stress à dobutamine
- E. Aucune investigation supplémentaire

11. Un patient de 42 ans consulte pour un 1^{er} épisode de douleur épigastrique après les repas augmentant en intensité depuis 2 semaines. Il n'a ni perte de poids, ni vomissement, ni dysphagie, ni hématurie ni méléna. Il a souvent des lombalgies, dont un épisode depuis 2 semaines traité par ibuprofène 3x600 mg/j.

Aucun autre antécédent médical ni traitement notable.

A l'examen clinique: BEG, afébrile, pouls=80/min, TA=128/78 mmHg. Peau bien colorée sans ictère. Douleur à la palpation de l'épigastre, sans défense ni détente ni signe de Murphy; pas de masse abdominale; bruits abdominaux normaux. TR normal.

Quelle stratégie d'investigation ou de prise en charge proposez-vous?

- A. « Breath test » à la recherche d'*Helicobacter pylori*
- B. Echographie abdominale
- C. Oeso-gastro-duodénoscopie
- D. Traitement par inhibiteur de pompe à protons
- E. Arrêt de ibuprofène et traitement par inhibiteur de pompe à protons

12. Une patiente de 41 ans est connue pour un asthme traité par du salbutamol (Ventolin®) en réserve. Elle consulte car elle a depuis une semaine une toux sèche, une dyspnée d'effort quotidienne et une dyspnée nocturne 1 nuit sur 2.

Examen clinique: afébrile. TA 105/70 mmHg. FC 60/'. FR 12/'. Sibilances expiratoires diffuses. PF 380 (80% de la valeur prédite). Sat O2 99%

Quel traitement lui proposez-vous?

- A. Hospitalisation en urgence
- B. β 2-agoniste à courte durée d'action
- C. Corticoïde inhalé
- D. Prednisone 0.5 mg/kg PO durant 4 semaines
- E. Corticoïde inhalé + β 2-agoniste à longue durée d'action

13. Un homme de 55 ans vous consulte pour le suivi de son hypertension artérielle traitée par inhibiteur d'enzyme de conversion, diurétique thiazidique et anticalcique. Malgré ce traitement, sa tension artérielle n'est pas contrôlée avec une moyenne des auto-mesures à 164/104 mmHg. Il fume depuis 40 ans avec 20 cigarettes/jour de longue date.

A l'examen, son BMI est de 24.8 kg/m^2 , la TA est à 180/114 mmHg. Les artères sont toutes palpables sans souffle. L'examen du fond d'œil montre une rétinopathie hypertensive stade 2. Le reste de l'examen clinique est normal.

Les examens de laboratoire sont normaux sauf une kaliémie à 2.8 mM/l

Quel examen complémentaire est le plus justifié à ce stade?

- A. Dosage immédiat du potassium dans les urines de 24h
- B. Dosage du cortisol urinaire sur 24h
- C. Dosage des métanéphrines urinaires
- D. Dosage de la rénine et de l'aldostérone plasmatique après interruption de IEC et diurétique
- E. IRM avec angiographie des artères rénales



1 Pill

Initial therapy
Dual combination

ACEi or ARB + CCB or diuretic

Consider monotherapy in low risk grade 1 hypertension (systolic BP <150mmHg), or in very old (>80 years) or frailer patients



1 Pill

Step 2
Triple combination

ACEi or ARB + CCB + diuretic



2 Pills

Step 3
Triple combination +
spironolactone or
other drug

Resistant hypertension
Add spironolactone (25-50 mg o.d.)
or other diuretic, alpha-blocker or beta-blocker

Consider referral to a specialist centre for further investigation

Beta-blockers

Consider beta-blockers at any treatment step, when there is a specific indication for their use, e.g. heart failure, angina, post-MI, atrial fibrillation, or younger women with, or planning, pregnancy

14. Un homme de 75 ans consulte pour son suivi trimestriel. Il présente:

- diabète de type II non compliqué traité par metformine 2 x 1 g/j
- hypertension artérielle traitée par lisinopril + HCTZ 20+12.5 mg/j
- dyslipidémie traitée par atorvastatine 20 mg/j
- BPCO modéré traité par tiotropium 18 ug/j

Depuis 3 mois l'hypertension est mal contrôlée (160-170/90-110 mmHg). Le patient dit prendre son traitement correctement à l'aide de son pilulier.

A l'examen: BMI = 29 kg/m², TA = 162/108 mmHg. Auscultation cardio-pulmonaire normale. Artères toutes palpables sans souffle. Pas de turgescence jugulaire ni d'oedèmes. Au fond d'œil, rétinopathie hypertensive stade 2. Le reste de l'examen clinique est normal.

Vous décidez de majorer son traitement anti-hypertenseur.

Quelle option thérapeutique est la plus adéquate?

- A. Augmenter la dose d'inhibiteur d'enzyme de conversion de angiotensine
- B. Ajouter un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (sartan)
- C. Ajouter un B-bloquant
- D. Ajouter un anticalcique
- E. Ajouter un inhibiteur de la rénine

15. Un patient de 55 ans, connu pour un diabète de type 2, une surcharge pondérale (IMC=28 kg/m²) et une HTA, consulte pour son suivi trimestriel. Il est traité par lisinopril 20 mg/j. Avec un traitement par régime et activité physique, son diabète était bien contrôlé avec l'HbA1c à 6,2% jusqu'à il y a 4 mois. Son poids est resté stable et son alimentation n'a pas changé.

Depuis 3 mois, son diabète est moins bien contrôlé avec des glycémies supérieures à 10 mM/l et l'HbA1C à 8,9%.

Quel traitement proposez-vous?

- A. Motiver à perdre du poids et faire plus d'activité physique
- B. Introduire de l'insuline intermédiaire matin et soir
- C. Introduire un traitement avec un inhibiteur SGLT-2
- D. Introduire un traitement avec une gliptine (= inhibiteur DPP-4)
- E. Introduire un traitement de metformine associé à un inhibiteur SGLT-2 ou un agoniste GLP-1